

إسم المريض ربيعاً : وفاء ربيع طه عويس

الحى / المدينة : اهناسيا

المحافضة : بنى سويف

رقم البطاقة : 27507302200628 رقم التلفون : 01068346440

العمر(تاريخ الميلاد) : 30-07-1975 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني + زولاديكس قسم العلاج :
[14165] الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

التوقيع: محمد يوسف

التوقيع: (م. ل. د. حسني)

التوقيع: (مؤمن رمضان)

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / د ----- / د ----- / د.ا ----- / د.ا

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جہۃ العلاج :-

ملاحظات : ---

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: وفاء ربيع طه عويس National ID: 27507302200628	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Plus Goserline
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

وفاء
ربيع طه عويس
اشمنت
مركز ناصر - بني سويف

٢٧٥٠٧٣٠٢٢٠٠٦٢٨

١٩٨٥/٠١/٠١

HY0132232

٢٠١٩/٠٣ ٢٧٥٠٧٣٠٢٢٠٠٦٢٨
ربة منزل

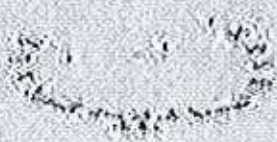
أفش
مسئبة
زوجة

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/٠٣/٠١

٦

21/06/2023, 10:39

Codo.42 - Name_A MDT form Hama - Name_E MDT form Hama



Ministry of Health and Medical Services
Kingdom of Saudi Arabia

الوزارة العامة للصحة
والخدمات الطبية
المملكة العربية
السعودية



A-Patient ID:

1- Name: **ولاء ربيع طه عويش**

Sex:

MDT form

3- Medical number:

Female

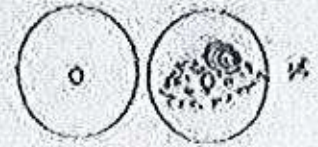
83143996

Old Med:

1053/2023

2-ID number: 27507303200820

Patient Age: 48 Y



Family history:

Phone:

BMI:

REASON OF MDY: NEW

marital status:

NRR Score:

GROUP:

A

Co-morbidity:

Menopausal
status:

Date of MDY:

2023-06-21 (7)

Clinical data

Breast Imaging:

Mets Workup:

FREE

BCI:

EC:

5/8

PR:

0/8

Her 2 Neu 1

3

SISH:

KIGZ:

21

T

4/8

N

1

M

0

Sonomammography

LT BREAST WITH 12 O'CLOCK MEASURING 44X26MM

PATIENT HISTORY

CT CAP, BONE SCAN: FREEE

MDT OUTCOME & PLAN

FOR Neoadjuvant in 6 YCHP

Clip insertion to help pathological assessment of PCR

patient will mostly go for MRM due to diffuse peau d orange

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

RADIOLOGY

SURGERY

PATHOLOGY

Psychiatric

Nutrition

Name: وفاء ربيع طه حسين		
MR. : 8782		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها The patient was diagnosed with left-sided breast cancer, clinical stage T4b N2, estrogen-receptor positive (ER 6/8), progesterone-receptor negative, HER2-negative, and was classified as recurrent disease. The treatment plan included left modified radical mastectomy (MRM) followed by adjuvant systemic therapy with the PHESGO regimen. The patient received PHESGO for a total of 17 cycles, the last administration occurring in August 2024. Ongoing supportive therapy includes zoledex and femara for a newly identified secondary malignancy.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	19-09-2026
	الوقت :	dina makram
الطبيب المعالج :		
يعتمد ,		



Patient Name	: الأم علاء / ولده ربيع طه عويس	Request No.	: 13007235
Patient No.	: 27507302200828	Request Date	: 24/05/2023
Path No.	: SR-619/23	Verification Date	: 04/06/2023
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - فئة الدولة
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data:

Left breast lesion

Nature of specimen:

Slide revision

Gross examination

6 slides (1484) + 1 block

Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5).

Microscopic examination:

* Histological type: Invasive duct carcinoma .

* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II

* DCIS: Could not be detected within the limits of biopsy received

*Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy received

*IPT:

ER: Moderate nuclear reaction in 60% of tumor cells (Allred score 6/8)

PR: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)

Her-2: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+)

Ki 67: 20 % nuclear reaction in tumor cells

Positive control showed appropriate reactivity

Diagnosis:

Left breast lesion, slide revision:

Invasive duct carcinoma, Grade II .

IPT:

ER: Positive (score 6/8).

PR: Negative (score 0/8).

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 08/06/2023 09:47:30

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



Patient Name	: الأبنكاد / رنا وبيع ماله عروس	Request No.	: 13007235
Patient No.	: 27607302200628	Request Date	: 24/05/2023
Path No.	: SR-619/23	Verification Date	: 04/06/2023
Sex	: Female	Financial Category	: أورام خارج المستشفى - فئة الدولة
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

HER-2: Positive (score 3+).
Ki67: Positive in 20% of tumor cells.

Prof. Gamal Abdelatty
Dr. Walaa Ghoneim
Dr. Esraa Magdy

Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 08/06/2023 09:47:30

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

Document generated by the Pathology Lab system. All rights reserved. No part of this document may be reproduced without prior written permission from the Pathology Lab.



Patient Name	: الأبنود / رانيا ربيع طه عيسى	Request No.	: 13002284
Patient No.	: 27507302200628	Request Date	: 11/11/2023
Path No.	: 3980/23	Verification Date	: 22/11/2023
Sex	: Female	Financial Category	: أورام داء السلام - نفقة المرأة
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer (post NACT) .
Nature of the specimen: Left MRM

Gross Examination:

- Procedure: Left MRM specimen measured 21x16x5.5 cm with covering skin ellipse measured 19x12cm & attached axilla 9x6 cm.
- Tumor extent: Sectioning showed a well inscribed tumour, ped site with loberry to tan grayish white cut section.
- Size: 3x1.5x1 cm.
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly.
- Distance from margins: 0.7 cm away from deep margin (least margin).
- Lymph nodes number and size: 23 L.Ns up to 2.5x0.8x0.6 cm.

Microscopic examination:

- Histological type: No residual viable tumor tissue detected
- Ductal carcinoma in situ: No
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Free L.Ns (0/23)
- Resection Margins: Free margins
- Histologic response to therapy: Pathologic Complete response
- Additional pathological findings: Giant cell reaction.

Diagnosis:

- Left MRM (post NACT) :
- No residual viable tumor tissue detected (total tumour burn out).
 - Free margins
 - Free nipple and areola
 - Free L.Ns (0/23)

Verified by :
DR.Menna Nabil

Printing Date : 29/11/2023 11:04:45

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



Room No. (1) - First Floor - Building No. 967 - New Giza - El-Dokki - Cairo, Egypt

Patient Name : الأم/الأب / ربيع مة يوسى	Request No. : 13002284
Patient No. : 27507302200628	Request Date : 11/11/2023
Path No. : 3980/23	Verification Date : 22/11/2023
Sex : Female	Financial Category : أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 48 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

- Pathologic Complete Response
- Stage : ypT0 , ypN0

Prof. Dr. Lubna Omar
Dr. Menna Nabil

Verified by :
DR.Menna Nabil

Printing Date : 29/11/2023 11:04:35

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



شركة رقم (4) - شارع النيل - مبنى رقم (287) - الميناء الجديد - القاهرة - مصر
Page No. (4) - First Floor Building No. 287 Nile Corniche - Mile El Qadima - Cairo, Egypt



S C A N

Name: Wafaa Rabeeh Taha

ID: 3459453

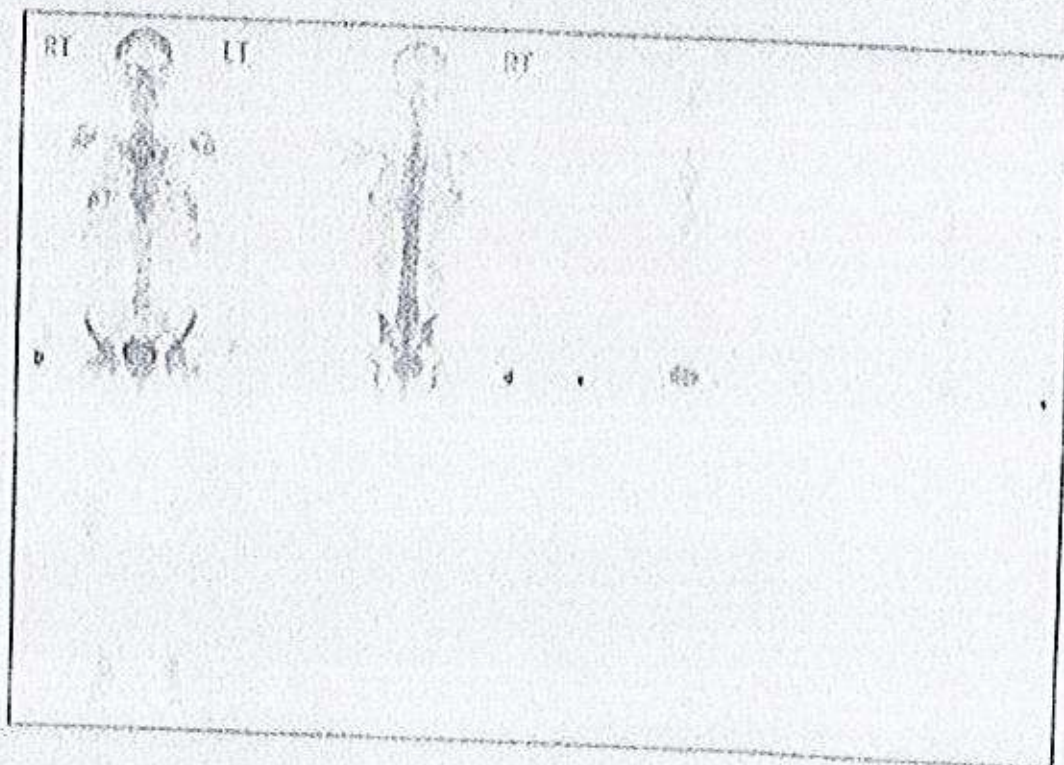
Date: 17/06/2023

REPORT

^{99m}Tc -MDP W.B. Bone Scan

Clinical data:

Complaint	Left breast cancer.
Labs	Not available.
Trauma/surgeries	No
Previous imaging	Not available.
Previous bone scan	
Technique:	
Injected dose	740 MBq
Images	Delayed whole body + spot view chest.



Findings:

- No abnormal osseous tracer uptake detected that would account for osseous lesions.
- Osteoarthritic changes of knees are noted.
- Mild degenerative changes of the spines are observed.

Impression:

- No scintigraphic evidence of metastatic osseous lesions.

Dr. Mohamed Omar, MD

Dr. Tordaws Badr

ID: 3459453

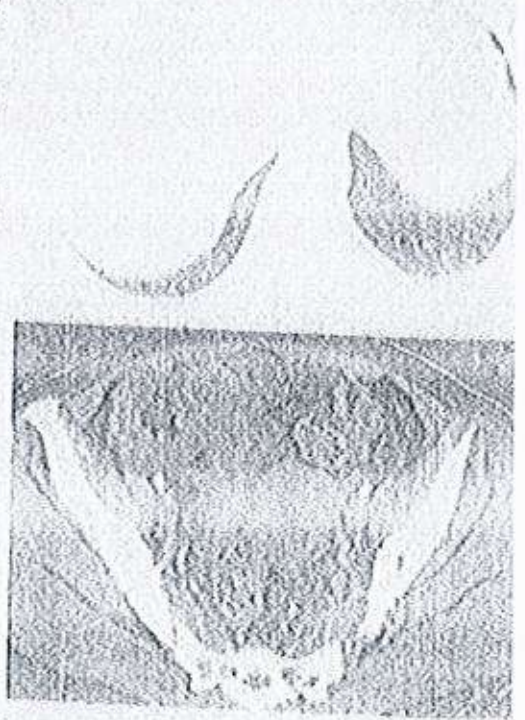
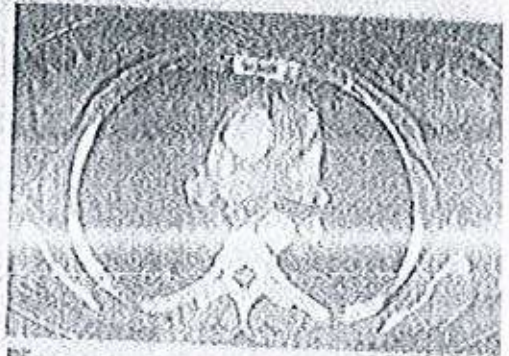
Name: Mrs. Wafaa Rabeea Taha
Date: 15/05/2023

128 Multislice C.T scan of the Chest, Abdomen and Pelvis was performed with I.V and without oral contrast enhancement revealed:

**** Status a known case of left breast neoplastic lesion post lumpectomy follow up study. The current study has revealed:**

CT Chest Findings:

- Asymmetrical thickened left breast skin is noted extending to the nipple + areolar complex with mild edematous changes inseparable from underlying glandular tissue.
- Left axillary lymph nodes are noted with largest one of about 19 mm.
- Right axillary small size non specific lymph nodes are noted with largest one of about 10 mm.
- Small patchy areas of mosaic lung configurations are noted involving both lower lung lobes with minimal interlobular septal thickening.
- The rest lung parenchyma appears well aerated with no obvious pulmonary mass lesion.
- The mediastinal vascular structures appear intact with no significant pathological enlarged mediastinal lymph nodes.
- The pleural recesses appear intact with no pleural effusion.



CT Abdomen and Pelvis Findings:

- The liver appears mildly enlarged in size measures about 17.8 cm at its maximum craniocaudal dimension with grossly intact parenchyma. There is no focal hepatic lesion or intrahepatic biliary radicles dilatation.
- The portal vein and its main divisions are patent.
- The spleen is not enlarged with grossly intact parenchyma.
- The pancreas and suprarenal glands appear intact.
- Both kidneys appear intact with no obvious impacted stones or back pressure changes.
- There are no significant pathological enlarged retroperitoneal lymph nodes or pelyabdominal collection.

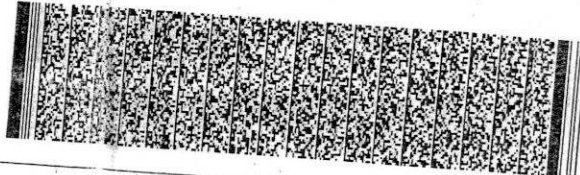
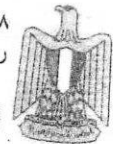


herring



ERM036726274

٢٠١٩/٠٣ ٢٧٥٠٧٣٠٢٢٠٠٦٢٨
ربة منزل
أنثى مسلمة
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/٠٣/٠٢



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

وفاء
ربيع طه عويس
اشمنت
مركز ناصر - بنى سويف

٢٧٥٠٧٣٠٢٢٠٠٦٢٨
HY0132232



٢٠١٩/٠٣
٢٧٥٠٧٣٠٢٢٠٠٦٢٨

فتح محمد هادي
٢٠١٩/٠٣
٢٧٥٠٧٣٠٢٢٠٠٦٢٨





Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : وقاء ربيع طه عويس

Sex:

3- Medical number:

Female

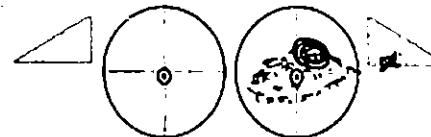
83142996

Old Med :

1853/2023

2-ID number: 27507302200628

Patient Age : 48 Y



Family history

Phone

BMI

REASON OF MDT

NEW

marital status

NRS Score

GROUP

Date of MDT

2023-06-21

Co morbidity

Menopausal status

Clinical data					
Breast Imaging :			Mets Workup : FREE		
BX:	ER: 6/8	PR: 0/8	Her 2 Neu : 3	SISH :	KI67 : 21
T 4B	N 1		M 0		
Sonomammography LT BREAST WITH 12 O'CLOCK MEASURING 44X26MM					
PATIENT HISTORY CT CAP , BONE SCAN : FREEE					
MDT OUTCOME & PLAN					
FOR Neoadjuvant ttt 6 TCHP Clip Insertion to help pathological assesment of PCR patient will mostly go for MRM due to diffuse peau d orange					

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	د/ شريف حسان	RADIOLOGY	د/ محمد عبد الله
SURGERY	د/ محمود عبد المنعم	PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : وفاء ربيع طه عويس

Sex:

3- Med cal number:

Female

83142996

Old Med :

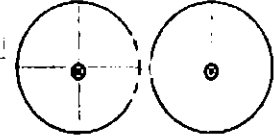
Old Med

1835-2023

2-ID number: 27507302200628

Patient Age : 48 Y

Post-NAC



Family history

Family History

Phone

Phone

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT

marital status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

Co morbidity

Co Morbidity

Menopausal status

Menopausal Status

2023-10-25

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

FREE

BX:

ER:

6/8

PR:

0/8

Her 2 Neu :

3

SISH :

KI67 :

21

BY COMMENT:

ER COMMENT:

PR COMMENT:

Her 2 Neu COMMENT:

SISH COMMENT:

T

4b

N

1

M

0

Sonomammography

LT BREAST WITH 12 O'CLOCK MEASURING 44X26MM

PATIENT HISTORY

pt with Lt LABC

received TCHP x6 with good clinical response

inserted clip

new SM R

last cycle → 7/11/20

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

patient received NACTH with good clinical response for Lt MRM

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د/ شيماء يونس	RADIOLOGY	RADIOLOGY د/ ناهد يحيى
SURGERY	SURGERY د/ محمد النجدي	PATHOLOGY	PATHOLOGY د/ محمد النجدي
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition د/ محمد النجدي



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : وفاء ربيع طه عويس

Sex:

3- Medical number:

Female

83142996

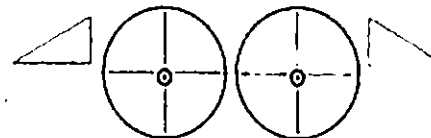
Old Med :

Old Med :

1835-2023

2-ID number: 27507302200628

Patient Age : 48 Y



Family history

Family History

Phone

Phone

01067918687

BMI

BMI

27

REASON OF MDT

REASON OF MDT
POST OPERATIVE

marital status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

1

GROUP

GROUP

A

Date of MDT

Date of MDT

03/12/2023

Co morbidity

Co Morbidity

Menopausal
status

Menopausal Status

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

FREE

BX

ER

PR

Her 2 Neu

SISH

KI67

6/8

0/8

3

21

BX COMMENT:

ER COMMENT:

PR COMMENT:

Her 2 Neu COMMENT:

SISH COMMENT :

T

N

M

4b

1

0

Sonomammography

LT BREAST WITH 12 O'CLOCK MEASURING 44X26MM

PATIENT HISTORY

pt with lt LABC

received TCHP x6 with good clinical response

Inserted clip

new SM R

patient received NACTH with good clinical response for Lt MRM, PCR

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

physego complete 17 cycles, port, zoladex and AI

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د. ربيع طه عويس	RADIOLOGY	RADIOLOGY د. ربيع طه عويس
SURGERY	SURGERY د. ربيع طه عويس	PATHOLOGY	PATHOLOGY د. ربيع طه عويس
Psychiatric	Psychiatric د. ربيع طه عويس	Nutrition	Nutrition د. ربيع طه عويس

Name	وناءى بىجىن	MRN	1835/2023
Age	48	ID	27507302200628
Menopausal status	post-menopausal	Phone	0100 9407080
NSS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	post-menopausal
		post NACT	11/12/21
Clinical Data			
BA. post 17 RM	R		
T46 N1 Mo			
Sonography			
No residual viable tissue			
- Free margins.			
- Free nipple + areola.			
- Free LNs. 0/23.			
Recommendation:			
MDT OUTCOME & PLAN			
SIGNATURE			



Patient Name: Wafaa Rabeea Taha Owais	Date : 03/02/2025
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 49 Year(s)
Medical ID: 1835/2023	Pat. ID: 42654

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Status post MRM for follow-up:

I Chest:-

- Left MRM showing no sizable masses or collection.
- Evidence of right axillary prominent lymph nodes.
- Bilateral predominantly lower lung lobes mosaic attenuation pattern.
- Left upper lobe subpleural reticulations and atelectatic bands are seen, Likely post radiation sequel.
- Bilateral mostly subpleural tiny nodules the largest is seen at right middle lateral segment, measuring about 4mm.
- Right lower superior segment atelectatic band.
- No pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No pathologically enlarged mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is mildly enlarged with homogenous CT texture. No definite focal lesions (on non contrast base) or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

***Scanned skeleton:**

- no definite worrisome lytic or sclerotic focal lesions.
- Tiny sclerotic lesions seen at right femoral head and left iliac bone, likely benign bony islands lesions.



Patient Name: Wafaa Rabeea Taha Owais	Date : 03/02/2025
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 49 Year(s)
Medical ID: 1835/2023	Pat. ID: 42654

Opinion:

Status post MRM

- Bilateral tiny nodules as described above, likely non specific, for follow-up.
- No evidence of hepatic or osseous metastatic deposits on non-contrast basis.

Dr. Khawla Ahmed
Dr . Maitha Fadhl

Dr. Walid Mohamed, M.D.



Patient Name: Wafaa Rabeea Taha Owais	Date : 03/02/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 49 Year(s)
Medical ID: 1835/2023	Pat. ID: 42654

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM in

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- scattered fibroglandular densities of the right breast (ACR B)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.



Patient Name: Wafaa Rabeea Taha Owais	Date : 07/10/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 1835/2023	Pat. ID: 42654

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

left breast pathologically proven malignant mass on NACT for assessment.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Left breast shows UOQ irregular mass lesion, of equal density with clip seen within.
- Complementary ultrasound revealed left breast irregular spiculated isoechoic mass lesion, seen at 1 o'clock measuring 1.1 x 0.9 cm (was 2.6x4cm, in prior study dated 15/5/2023)
- No right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex of the right breast.
- Nonspecific right axillary LN.
- Regression of left axillary lymph nodes with cortical thickness 3.1 mm compared to 7 mm.
- Free left infra and supra-clavicular regions.

Opinion:

- Good radiological response of the left breast malignant mass (BIRADS 6)

Yours truly

Dr. Wafaa Ali



Echo report

MR: 1820
22

Name: وفارسيه
Date: 27/1/2023

EF	57%	55-75%	PWT	0.85	
LVEDD	4.50	3.5-5.8cm	AO.R	1.75	2-3.7cm
LVESD	3.14	2-4cm	LA	2.85	2-4cm
FS	30%	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.85	0.6-1.1cm	AO.CUSP	-	1.5-2.6cm

LV dimensions Normal

LV wall thickness Normal

LV diastolic function DDI

SWMA No gross SWMA

LA and Aortic root dimensions Normal

Mitral Valve normal morphology, MR grade I/II

Aortic valve Normal

Tricuspid valve Normal

Pulmonary valve Normal

Right side and systolic function Normal, TAPSE: 18mm

Intracardiac masses and effusion No masses, no effusion

D/ Msc cardiology



Echo report

وفار ربيع

MR: 1820
CF

Name:

Date: ٢٢/٧/ 2024

EF	67.1	55-75%	PWT	0.8	0.6-1.1cm
LVEDD	4.9	3.5-5.8cm	AO.R	2.9	2-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	3.4	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.8	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

- LVDimensions normal
- LV wall thickness normal
- LV diastolic function normal
- SWMA normal
- LA and Aortic root dimensions normal
- Mitral Valve normal
- Aortic valve normal
- Tricuspid valve normal TR
- Pulmonary valve normal
- Right side and systolic function normal
- Intracardiac masses and effusion normal

D/Msc cardiology

د/مستشار



Echo report

MR: 1820/12

Name:

Date: 22/6/2023

EF	64	55-75%	PWT	0.7	
LVEDD	4.8	3.5-5.8cm	AO.R	2.7	2-3.7cm
LVESD	3.2	2-4cm	LA	2.5	2-4cm
FS	34	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.7	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions

LV wall thickness

LV diastolic function

SWMA

LA and Aortic root dimensions

Mitral Valve

Aortic valve

Tricuspid valve

Pulmonary valve

Right side and systolic function

Intracardiac masses and effusion

D/ Msc cardiology

Dr. Nasser Elber

Dr. Nasser Elber

Echo report

Name:

Date: / / 2023

EF		55-75%	PWT		0.6-1.1cm
LVEDD		3.5-5.8cm	AO.R		2-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA		2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT		0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions

LV wall thickness

LV diastolic function

SWMA

LA and Aortic root dimensions

Mitral Valve

Aortic valve

Tricuspid valve

Pulmonary valve

Right side and systolic function

Intracardiac masses and effusion

D/ Msc cardiology



Echo report

MR: ١٨٢٥/٩

Name:

Date: 7/10/2023

EF	62%	55-75%	PWT	2.71	
LVEDD	4.84	3.5-5.8cm	AO.R	2.09	2-3.7cm
LVESD	3.21	2-4cm	LA	2.50	2-4cm
FS	33%	25-45%	RV	—	0.7-2.3cm(supine)
SWT	1.07	0.6-1.1cm	AO.CUSP	—	1.5-2.6cm

LV dimensions

Normal

LV wall thickness

Normal

LV diastolic function

DDI

SWMA

No SWMA

LA and Aortic root dimensions

Normal

Mitral Valve

Normal

Aortic valve

Normal

Tricuspid valve

Normal

Pulmonary valve

Normal

Right side and systolic function

not Dilated, TAPSE 25mm

Intracardiac masses and effusion

No effusion, no masses

D/ Msc cardiology

د. محمد ربيع



Patient Name	: الأستاذة / وفاء ربيع طه عويس	Request No.	: 13007235
Patient No.	: 27507302200628	Request Date	: 24/05/2023
Path No.	: SR-619/23	Verification Date	: 04/06/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data:

Left breast lesion

Nature of specimen:

Slide revision

Gross examination

6 slides (1484) + 1 block

Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5).

Microscopic examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma .
- * Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II
- * DCIS: Could not be detected within the limits of biopsy recieved
- *Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy recieved
- *IPT:

ER: Moderate nuclear reaction in 60% of tumor cells (Allred score 6/8)

PR: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)

Her-2:Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+)

Ki 67: 20 % nuclear reaction in tumor cells

Positive control showed appropriate reactivity

Diagnosis:

Left breast lesion, slide revision:

Invasive duct carcinoma, Grade II .

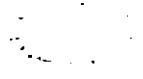
IPT:

ER: Positive (score 6/8).

PR: Negative (score 0/8).

Verified by :

dr.esraa magdy



Patient Name	: الأستاذة / وفاء ربيع طه عويس	Request No.	: 13007235
Patient No.	: 27507302200628	Request Date	: 24/05/2023
Path No.	: SR-619/23	Verification Date	: 04/06/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

HER-2:Positive (score 3+).

Ki67: Positive in 20% of tumor cells.

Prof.Gamal Abdelatty
Dr.Walaa Ghoneim
Dr.Esraa Magdy

Verified by :
dr.esraa magdy

Dr.
NADIA M. MOKHTAR

*Professor of Pathology
Cancer Institute, Cairo University*

دكتورة
نادية محمود مختار

*أستاذ الباثولوجي
معهد الأورام، جامعة القاهرة*

Name: وفاء ربيع طه عويس

Age: 47

Clinical : LEFT SUSPICIOUS BREAST MASS

Nature: CORE BIOPSY

DR: د. عبدالعزیز زین العابدین

1484 / 23

Pathology Report

Gross: Fragmented cores, 1.5 cm.

Micro: Breast tissue is invaded by few groups of duct carcinoma cells. They show high anaplasia, degenerative features and no tubule formation. Stroma is fibro-inflammatory.

Diagnosis: LEFT BREAST, CORE BIOPSY: INVASIVE DUCT CARCINOMA, GRADE 3.

07-May-2023

Prof. Nadia Mokhtar



Dr.
NADIA M. MOKHTAR

*Professor of Pathology
Cancer Institute, Cairo University*

دكتورة
نادية محمود مختار

*أستاذ الباثولوجي
معهد الأورام - جامعة القاهرة*

Name: وفاء ربيع طه عويس

Age: 47

Clinical : LEFT BREAST CANCER

Nature: CORE BIOPSY FOR IMMUNOPHENOTYPING

DR: د. محمد عبدالواحد

1484 / 23

Pathology Report

Gross: Fragmented cores, 1.5 cm.
IMMUNOPHENOTYPING:
Sections are stained using ER, PR, Her-2 and Ki-67 antibodies with Ventana Gx Immunostainer.

Micro: Immunophenotyping:
All tumor cells are negative for nuclear staining of ER.
About 10% of tumor cells are positive for nuclear staining of PR with weak intensity.
Many invasive tumor cells more than 10% show complete thick membranous staining of Her-2.
Ki-67=25%.

Diagnosis: LEFT BREAST, CORE BIOPSY FOR IMMUNOPHENOTYPING: ER NEGATIVE, 0/8, PR WEAK POSITIVE 3/8, HER-2 POSITIVE (SCORE +3), KI-67=25%.

17-May-2023

Prof. Nadia Mokhtar





Patient No. : 1835-2023
Patient Name : الأستاذ / وفاء ربيع طه عويس
Sex : Female Age: 50 Y
Financial Cate : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Referring Doc :

Request No : 13007279
Request Date : 27-01-2025 13:38
Verification Date : 27-01-2025 19:24
Sample Type : Serum
Test Status : Routine
Analyzers : Mini_Vidas_Hermel

Hormones&Tumor Markers Report

Test	Result	Unit	Ref. Range
CEA	1.62	ng/mL	Non Smoker : (0.8 - 2.5) Smoker : (1.3 - 4.9)
Ca 15-3	20.60	U/ml	6.40 - 58.00)

Signature

Dr.Reaam Abd El Menaem

Printing Date : 03/02/2025 10:57:39

Page 1 of 1

Printing By : 3laa Eid

25311121 / فاكس

25311128 - 25311125 / ت

987 كورنيش النيل المئك الصالح

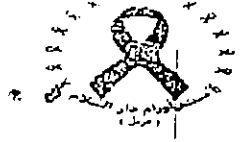


وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام (هرمل)
الصيدلة الإكلينيكية

Docetaxel Protocol Cycle (...)

اليوم:		التاريخ: 2021/.../...	
اسم المريض: ...		رقم الملف: ...	
Weight: 67.7 kg	Height: 145 cm	BSA: 1.7 M2	Age: 48 years
CBC:	WBC:	ANC:	Hgb: PLT:
Functions Tests:	Sr.Creat:	Urea:	
	ALT:	AST:	T.Bil: D.Bil:
Dose Modification: % Echo: EF: 64% 22/6/2023			
Reason: ☐ Hematological ☐ Non hematological:			
الصرف	بروتوكول العلاج		
امضاء التمريض			
	جرانيسترون (0.01 مجم/كجم) مجم + ديكساميثازون 12 مجم + انتودين 20 مجم + امبول افيل في 50 مل ج 5% علي مدي ربع ساعة قبل العلاج الكيميائي. (Maximum dose of Granisetron =1mg)		
	دوسيتاكسل (75 مجم/م2) 2.7 مجم في 500 مل ج 5% علي مدي ساعتين.		
	50 مل ج ملح علي مدي 10 دقائق		
العلاج التدايمي:		كاونترولوك قرص 40 مجم علي الريق لمدة اسبوع. ديكساميثازون 8 مجم (امبول او قرص) كل 12 ساعة لمدة 3 ايام تبدأ اليوم السابق للجرعة.	
Physician Signature:		Clinical pharmacy:	Dispensing pharmacy:
د.		C ₁ TXT/6000 [545mg] + C ₁ phargo 1200/600 C ₁ ph / ...	

2021/6/22



م	اليوم/التاريخ	اسم الجرعة	رقم الجرعة	امضاء				ملاحظات
				الطبيب	الصيدلية الاكلينيكية	صيدلية الصرف	صيدلية التحضير	
1	3/1/18	phesgo	C11		م. علي محمد			not taken
2	4/1/18	phesgo	C11		م. ص. م. م.	م. س. م.	Dr. Hadou	
3								
4	5/1/18	phesgo	C13		م. م. م.	م. م. م.	م. م. م.	
5	6/1/18	phesgo	C14		م. م. م.	م. م. م.	م. م. م.	
6	7/1/18	phesgo	C15		م. م. م.	م. م. م.	م. م. م.	
7								
8	8/1/18	phesgo	C17		م. م. م.			
9								
10								
11								
12								
13								
14								



اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف: ١٩٢٥١٩

Doctor's Orders

التشخيص: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
13/04/2024		منشور سبيلت تحت الجلبه فيما را من ١٤١ ساعة ١٤١ ساعة وان انا من ١٤١ ساعة كلاريفيكا من ١٤١ ساعة بارامبريكا من ١٤١ ساعة ميكادريم كريم رولون من ١٤١ ساعة	

EF 68%
(8/4/2024)

C13 phsego
CLPh/خارج
(20/5/2024)

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة ومرفوعة من الطبيب
د.
ن.

اسم المريض ثلاثي: عفا د. ربيع
رقم الملف: ٤٢/٨٢٥



وزارة الصحة و السكان
أمثلة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

.....: نوع التغذية: التشخيص

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

Doctor's Orders اوامر الطبيب

.....: نوع التغذية:

81412624

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

مباحث اصول و فقه

رقم الملف:

8/5 Pm

التَّشخيص:

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

التشخيص: **نوع التغذية:**

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب



التشخيص:..... **نوع التغذية:.....**

آولہ داس
+ ۲۴
۱۷۱۷

۱۵۶ - مینا میں



اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

Doctor's Orders الاوامر الطبيب

التشخيص: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
	①	زوجة لا ديسين ١٠/٨... بتستعمل على	
		المسطن	
	②	كيمارا ٩.٥... هلم طبة شهر	
	③	كالسيوم	
	④	وانف النقا	
	⑤	ويلا تكتنو	
	⑥	بينادول وجا ١٢ ساعة	
		طبة هاليوم	
	⑦	Approval for	
		meta	
		م. اسه الطوف	
		CO(A) 17	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

رقم الملف:



وزارة الصحة و السكان
أمثلة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرميل"
إدارة الجودة

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

التشخيص: **نوع التظنية:**

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

التشخيص: **نوع التغذية:**

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:



وزارة الصحة و السكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أودام دار السلام " هرمل"
إدارة الجودة

Doctor's Orders الأوامر الطبيب

التشخيص: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
5/2/2024		9. عاتق 600 سم زولديكي عيار امول 1/0 11/2/2024 Pheno Cl. ph 10	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

.....: نوع التغذية:

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لا بد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف: ٢٢٢/



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

التشخيص: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		lt MRM → PCR for adj physgo 1 yrs C6 4/12/2023 C6 physgo al ph / C6 physgo al ph /	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرميل"
إدارة الجودة

.....: **التشخيص:**: **نوع التغذية:**

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		EP 62% C.B. J. Sandy 7/6 (190) ماكسست (375) كاسير 7-17 (2) طاسير ارن موتيسيم موي فامريتا موي	
			Ca C₆TCHP ارموداعاد CCN 1.1.18

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

..... إسم المريض ثلاثي:
..... رقم الملف:

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

التشخيص: **نوع التغذية:**

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
			C5
			ارسله لمرم + لاديا (دور ٢ + ٥ زرين)
			نا كوير (١٥) ٣ - ٢ - ٥ - ١
			كور بولاجيم ١٥
			ح سريخ بوم امد بوب
			برم ام بوم ١٥
			تجربتي ١٥
			مكيا بوم ١٥
			ميدجو ١٥
			١٩/١٢
			C5/TX/Carb [392]
			+ C4phcyo
			ص الشرح
			١٩/١٢
			new ccho R not cy

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام (هرمل)
الصيدلة الإكلينيكية

TC Protocol Cycle (.....)

اليوم:		التاريخ: 2021 / /	
اسم المريض:		رقم الملف:	
Weight: kg	Height: cm	BSA: M2	Age: years
CBC:	WBC:	ANC:	Hgb: PLT:
Functions Tests:	Sr.Creat:	Urea:	
	ALT:	AST:	T.Bil: D.Bil:
Dose Modification: %			
Reason: ☐ Hematological ☐ Non hematological:			
الضرف	بروتوكول العلاج		امضاء التمريض
	جرانيسترون (0.01 مجم/كجم) مجم + ديكساميثازون 12 مجم + انتودين 20 مجم + امبول افيل في 50 مل ج 5% علي مدي ربع ساعة قبل العلاج الكيماوي. (Maximum dose of Granisetron = 1mg)		
	دوسيتاكسل (75 مجم/م) 27... مجم في 500 مل ج 5% علي مدي ساعتين.		
	50 مل ج/ملح علي مدي 10 دقائق		
	سايفان (600 مجم/م) مجم في 250 مل ملح علي مدي 1/2 ساعة		
	50 مل ج/ملح علي مدي 10 دقائق		
العلاج التذعيمي:		كونترولوك قرص 40 مجم علي الريق لمدة اسبوع.	
ديكساميثازون 8 مجم (امبول او قرص) كل 12 ساعة لمدة 3 ايام تبدأ اليوم السابق للجرعة		جرانيسترون قرص 1 مجم كل 12 ساعة اليوم الثاني و الثالث.	
اونداالينز 8 مجم قرص كل 12 ساعة اليوم الثاني و الثالث.		دوسيتاكسل 27... مجم في 500 مل ج 5% علي مدي ساعتين.	
Physician Signature:		Clinical pharmacy: C4 TX T (128) C (492mg) , Srcr 0.8 + C3 phesgo	
Dispensing pharmacy:		2418 Cph / م / م / م	



ABW → 54

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام (مرمل)
الصيدلة الإكلينيكية

Docetaxel / Carboplatin AUC 5 Protocol Cycle (.....)

التاريخ: 2021/.../...		اليوم:	
رقم الملف: ٤١١٨٤٥		اسم المريض: د. أحمد	
Weight: 67. kg	Height: 145. cm	BSA: 1.64 M2	Age: 48. years
CBC:	WBC:	ANC:	Hgb: PLT:
Functions Tests:	Sr.Creat:	Urea:	CrCL:
	ALT:	AST:	T.Bil: D.Bil:
Dose Modification: %			
Reason: ☐ Hematological ☐ Non hematological:			
امضاء التمريض	بروتوكول العلاج		الصرف
	جرانيسترون (0.01 مجم/كجم) مجم + ديكساميثازون 12 مجم + انتودين 20 مجم + امبول افيل) في 50 مل ج 5% علي مدي ربع ساعة قبل العلاج الكيماوي. (Maximum dose of Granisetron = 1mg)		
	دوسيتاكسل (75 مجم/م2) 2.7. مجم في 500 مل ج 5% علي مدي ساعتين.		
	50 مل ج/ملح علي مدي 10 دقائق		
	كاربوبلاتين (AUC 5) مجم في 500 مل ج 5% علي ساعة.		
	50 مل ج/ملح علي مدي 10 دقائق		
العلاج الكيميائي: كونترولوك قرص 40 مجم علي الريق لمدة اسبوع. ديكساميثازون 8 مجم (امبول او قرص) كل 12 ساعة لمدة 3 ايام تبدأ اليوم السابق 125 قرص 80 مجم اليوم الاول و 80 مجم اليوم الثاني و الثالث. تأثيره اضعف دستور جيد يؤذي من نوبه سر			
Physician Signature:	Clinical pharmacy:	Dispensing pharmacy:	
	C3 Taxotere Carbu 418 C2 Phesgo C. A. J. H. H. م. ا. د. ع. ا. ب. د. ي		

إسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أودام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

Doctor's Orders الأوامر الطبيب

التشخيص: نوع النغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		C3.TC	
		C2.HP	
		د. البدر ٨/٣ ١٠	
		C1.TC	
		C3.HP	
		د. البدر ٨/٣ ١٠	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام (هرمل)
العيادة الإكلينيكية

TCHP Q 3 weeks Cycle (مستأجر)

اليوم: التاريخ: 2023 / ١٢ / ١٢		اسم المريض: د. وفاء ربيع محمد جريسي	
رقم الملف:		Weight: 67 kg Height: 145 cm BSA: 1.6 M2 Age: 48 years	
CBC:	WBC: ANC: Hgb: PLT:	Functions Tests: Sr.Creat: 2 Urea: CrCL: 48.9	
ALT: AST: T.Bil: D.Bil:		Echo: Date: 22/6 EF: 64.4 %	
Dose Modification: %			
Reason: ☐ Hematological ☐ Non hematological:			
امضاء التمريض	بروتوكول العلاج		الصرف
	جرانيسترون (0.01 مجم/كجم) مجم + ديكساميثازون 20 مجم + انتودين 20 مجم + امبول افيل) في 50 مل ج 5% علي مدي ربع ساعة قبل العلاج الكيماوي. (Maximum dose of Granisetron = 1mg)		
	برتوزوماب مجم في 250 مل ملح علي مدي 1/2 ساعة (علي مدي ساعة في الجرعة الاولى) فسيو حقنات اكبر Loading Dose: 840 mg Maintenance Dose: 420 mg		
	تراستوزوماب 600 مجم تحت الجلد لمدة 5 دقائق في الفخذ.		
	باكليتاكسل (75 مجم/م2) 1.27 مجم في 500 مل ج 5% علي مدي 3 ساعات		
	50 مل ج/ملح علي مدي 10 دقائق		
	يكزوبلاتين (AUC 5) مجم في 500 مل ج 5% علي مدي ساعتين.		
	50 مل ج/ملح علي مدي 10 دقائق		
كونترولوك قرص 40 مجم علي الريق لمدة اسبوع. ديكساميثازون 8 مجم قرص يوميا من اليوم الثاني للرابع. ايمند قرص 125 مجم اليوم الاول و 80 مجم اليوم الثاني و الثالث. بارسودين 100 مجم ام/اص م/صا ثلثي جرعة اسبوعيه قبل انكل ميكونازول 400 مجم فموي دواء لمرات تاسنم حبة فموية للقرص			
Physician Signature:	Clinical pharmacy:	Dispensing pharmacy:	
	د. ن. / ١٢ / ٢٣ ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٣ ٢٢٤ (370mg) ١١ - ١٢ - ١٣		

عيادة خارجي
١٧/١٢/٢٣
العلاج الكيميائي
دار السلام



اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

اوامر الطبيب Doctor's Orders

التشخيص: نوع التغطية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
13/7/2023		pt received 1 cycle letosteron Carboplatin today for C2 TC C1 HP	
12-1	2000		
383 cm			

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص:..... نوع التغذية:..

47,430(d)

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب